

Como ler esta folha classificação da evidência

O score é **PRIO-ACS** = $C_1 + C_2 + C_3 + C_4$, de 0 a 100, por paciente. Cada constante recebe uma classe de evidência, que diz **de onde vem o número** — e, quando não vem de norma, diz isso com todas as letras.

NORMA

O valor ou a regra está fixado em norma oficial. O trecho literal é reproduzido nesta folha.

DERIVADO

Conversão aritmética direta de um trecho de norma (ex.: “Trimestral” → 90 dias). A conta é mostrada.

CALIBRAÇÃO

Escolha de engenharia. Nenhuma norma fixa o valor. O critério usado é declarado e o número deve ser validado no piloto.

Fonte da verdade: `engine/scoring.py` e `config/rio-de-janeiro.yaml` (`Visitare/visitare-engine`) — todo número desta folha foi conferido contra os dois. Páginas citadas como PDF p.N (impressa p.M).

C₁ · Carga de condição crônica sensível 0 a 35 no código: c1_icsap

Conta quantas das três condições crônicas o paciente tem — hipertensão, diabetes, gestação — e soma pesos **decrecentes**, na ordem em que aparecem.

$$n = \text{hipertenso} + \text{diabético} + \text{gestação} \quad \cdot \quad C_1 = \text{soma dos } n \text{ primeiros pesos de } [15, 12, 8] \rightarrow n=0 \rightarrow 0 \cdot 1 \rightarrow 15 \cdot 2 \rightarrow 27 \cdot 3 \rightarrow 35$$

PARÂMETRO	VALOR	CLASSE	POR QUÊ
geram prioridade de visita	HAS · DM · gestação	NORMA	As três são nomeadas nas normas de visita do ACS como motivo de acompanhamento periódico ou de maior frequência . É isto — e só isto — que as habilita a pontuar numa lista de visita.
por que estas três	critério de seleção	DERIVADO	A Lista Brasileira de ICSAP (grupos 9, 13 e 19) é o filtro que separa condições cuja descompensação resulta em internação evitável pela APS. Define quais condições entram — não quanto o paciente pontua.
pesos [15, 12, 8]	decrecente	CALIBRAÇÃO	Critério: manter a função monotônica (acrescentar comorbidade nunca reduz o score) e fazer a 3ª condição fechar exatamente no teto de 35, sem cap artificial. Nenhuma norma fixa esses pesos.
teto 35	35	CALIBRAÇÃO	Orçamento do score: 35 + 25 + 25 + 15 = 100. A divisão entre os quatro componentes é decisão de modelagem, não de norma.

- “**Trimestral**: hipertensos, diabéticos (...)” — *cadência mínima de visita do ACS.*
- “**Maior atenção e frequência de visitas domiciliares (...): Diabetes e/ou hipertensão sem acompanhamento** ;”
- “**Alguns exemplos de situação de risco: (...) Gestantes com diabetes e/ou pressão alta** ;”

Carteira de Serviços APS – SMS-Rio, 2021, PDF p.47 (impressa p.46) [F2] · Guia Prático para o ACS, PDF p.177 (impressa p.175) [F3] · Manual do ACS, PDF p.29 (impressa p.27) [F6]

“Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária”

GRUPO 9 – **Hipertensão** – I10, I11

GRUPO 13 – **Diabetes melitus** – E10.0, E10.1 (...) E14.9

GRUPO 19 – **Doenças relacionadas ao Pré-natal e Parto** – O23, A50 e P35.0

Portaria SAS/MS nº 221, de 17 de abril de 2008 – Anexo, 19 grupos CID-10. [F1]

ICSAP classifica internações, não pessoas — por isso ele seleciona, mas não pontua. A Lista Brasileira é indicador de desempenho do sistema, apurado retrospectivamente sobre internações que já ocorreram. **Ter hipertensão não faz de alguém um caso ICSAP; ser internado por crise hipertensiva faz daquela internação uma ICSAP.** A Portaria fixa que o grupo 9 se chama “Hipertensão” — não fixa que um hipertenso valha 15 pontos numa lista de visita. Soma-se a isso que o grupo 19 é “doenças relacionadas ao pré-natal e parto” (O23, A50, P35.0): **gestação em si não está na lista.**

Nome no código diverge desta folha. No motor este componente ainda se chama `c1_icsap` e é gravado como `score_icsap` na tabela `allocations`. A renomeação está **pendente** — quem cruzar esta folha com o banco deve ler `score_icsap` como carga de condição crônica, e **não** tentar validá-lo contra taxas reais de ICSAP: ele não mede isso.

C₂ • Fase da vida vulnerável 0 a 25 usa o maior, nunca soma

Três fases marcadas como prioritárias. O componente pega o maior valor aplicável — não soma.

C₂ = máx(25 se gestante ; 20 se criança 0-6 ; 15 se idoso 66+ com HAS ou DM ; 0)

PARÂMETRO	VALOR	CLASSE	POR QUÊ
quais fases	gestante · criança · idoso c/ crônica	NORMA	A lei do ACS lista gestante e criança como alvos de visita regular e periódica ; o Guia Prático do MS define explicitamente o idoso com crônica sem acompanhamento como caso de maior frequência de visita.
ordem 25 > 20 > 15	ordenação	DERIVADO	Segue a cadência mínima que a Carteira de Serviços impõe a cada grupo: gestante mensal (semanal se alto risco) → criança mensal a semestral conforme a idade → idoso ≥ 60 semestral . Cadência mais curta na norma → peso maior no score.
magnitudes 25/20/15	25 · 20 · 15	CALIBRAÇÃO	A ordem é derivada da norma; os valores não. Nenhuma norma diz que gestante vale 25 e criança 20.
máx() em vez de soma	máx()	CALIBRAÇÃO	Cada peso já representa o impacto total daquela fase; somar distorceria o orçamento (uma gestante idosa marcaria 40 em um componente de teto 25).

“IV – a realização de **visitas domiciliares regulares e periódicas** para acolhimento e acompanhamento: a) da **gestante**, no pré-natal, no parto e no puerpério; b) da lactante, nos seis meses seguintes ao parto; c) da **criança**, verificando seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de sua altura; (...)”

Lei nº 11.350/2006, art. 3º, §3º, IV – redação dada pela Lei nº 13.595/2018. [F4]

“**Maior atenção e frequência de visitas domiciliares** devem ser feitas para os(as) idosos(as) que apresentarem os seguintes dados:”

- “Queda ou internação nos últimos seis meses;”
- “**Diabetes e/ou hipertensão sem acompanhamento** ;”
- “Paciente que não faz acompanhamento regular de saúde;”
- “Idoso que fica sozinho e que tem várias doenças crônicas (...);”
- “Acamados ou com dificuldade de se locomover até a UBS.”

“Esses casos devem ser priorizados pelo fato de implicarem maior risco de incapacidades e mortalidade.”

Guia Prático para o ACS – Ministério da Saúde, PDF p.177 (impressa p.175). [F3]

Ponto de corte etário não bate com nenhuma fonte. O motor usa **66+** porque é o que a faixa etária do dataset da SMS-Rio oferece. A Carteira de Serviços fala em **idosos (≥ 60 anos)** e a ERF-CS pontua **maior de 70 anos**. Nenhuma das duas é 66. É uma limitação do dado de entrada, não uma escolha clínica — e desloca uma faixa de 6 anos (60–65) para fora do C₂.

Gestação pontua duas vezes — questão em aberto. Uma gestante recebe **15 em C₁** (carga crônica) e **25 em C₂** (fase da vida): **40 dos 100 pontos** antes de qualquer lacuna de cuidado ou vulnerabilidade social. São eixos distintos e a soma é **intencional**, mas nenhuma norma fixa 40. O efeito prático é que **toda gestante entra pelo menos em Médio** (garantido por teste: `test_gestante_at_least_medio`). Se a SMS considerar 40 alto demais, o ajuste natural é reduzir a parcela de C₁ — não a de C₂, que é a que carrega a prioridade zero de mortalidade materna.

C₄ • Vulnerabilidade social

0 ou 15

desempate

Marcador sim/não já existente na base. Entra como critério de desempate entre perfis clínicos parecidos.

C₄ = 15 se situacao_vulnerabilidade ; senão 0

PARÂMETRO	VALOR	CLASSE	POR QUÊ
existir o componente	sim	NORMA	A PNAB manda priorizar por vulnerabilidade; a lei do ACS manda acompanhar grupos de risco com maior vulnerabilidade social; a Carteira do Rio manda dar atenção especial a CFC/Auxílio Brasil.
peso 15	15	CALIBRAÇÃO	Menor peso dos quatro componentes, deliberadamente: determinante social prediz risco de longo prazo , não urgência do dia.
binário	0 ou 15	CALIBRAÇÃO	Limitação do dado: a base traz um sim/não. Substituição prevista pelo IDS-Rio (contínuo) quando o índice estiver disponível por setor censitário.

“a atividade do ACS deve se dar pela lógica do planejamento do processo de trabalho a partir das necessidades do território, com priorização para população com maior grau de vulnerabilidade e de risco epidemiológico ;”

PNAB – Portaria GM/MS nº 2.436/2017, Anexo, item 3.4. [F5]

“ATENÇÃO: paciente que possui o Cartão Família Carioca (CFC) e Auxílio Brasil , devido a um maior risco social , deve receber atenção especial sempre que procurar a unidade.”

Carteira de Serviços da APS – SMS-Rio, 2021, PDF p.88 (impressa p.87). [F2]

Inversão de peso em relação à escala nacional — ponto de atenção para auditoria. Na ERF-CS os marcadores sociais pesam mais que os clínicos: baixas condições de saneamento = 3, desemprego = 2, analfabetismo = 1, contra HAS = 1 e DM = 1. No PRIO-ACS a relação se inverte: o social vale no máximo 15 e o clínico até 35. É uma escolha de produto (a lista do dia é de urgência clínica, e o social entra como desempate) — mas **contraria a proporção da escala nacional** e deve ser decidida explicitamente pela SMS antes do piloto.

Por que o motor existe

o problema, nas palavras da fonte

“A necessidade de priorizar VD em equipes com grande número de usuários , somada à ausência de critérios objetivos disponíveis para esta priorização são os grandes responsáveis pela ampla utilização da ERF-SC no nível nacional.”

ERF-CS – JMPHC, 2012, p.2. [F7]

“III – Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de maior número de visitas domiciliares ;”

PNAB – Portaria GM/MS nº 2.436/2017, Anexo – atribuições do ACS. [F5]

Canal A • Emergência recente 0 a 15

Conta idas não-eletivas à UPA e internações na janela (n). **Satura:** o 1º episódio pesa mais que os seguintes.

$$\text{pontos} = 15 \times (1 - e^{(-0,92 \cdot n)}) \rightarrow n=1 \rightarrow 9,0 \cdot 2 \rightarrow 12,6 \cdot 3 \rightarrow 14,1 \cdot 5 \rightarrow 14,8$$

PARÂMETRO	VALOR	CLASSE	POR QUÊ
contar internação/urgência	sim	NORMA	O Guia Prático do MS manda aumentar a frequência de visita após internação — é o gatilho explícito de reforço de acompanhamento.
janela	90 dias	CALIBRAÇÃO	Ancorada na cadência trimestral dos crônicos na Carteira: a janela cobre um ciclo completo de acompanhamento. Não é o que a fonte do gatilho diz — ver ressalva abaixo.
teto do canal	15	CALIBRAÇÃO	Evento já ocorrido pesa mais que atraso (risco de). Por isso 15 contra 10 do canal B.
K (saturação)	0,92	CALIBRAÇÃO	Critério declarado: 1 evento já entrega ~60% do canal (9,0 de 15) e o efeito satura no 3º (14,1). Reconhece a “porta giratória” sem deixar que 5 idas à UPA dominem o perfil clínico. Nenhuma norma ou estudo fixa 0,92 — é ajuste de curva.

“Maior atenção e frequência de visitas domiciliares devem ser feitas para os(as) idosos(as) que apresentarem os seguintes dados: **Queda ou internação nos últimos seis meses**,”

Guia Prático para o ACS — Ministério da Saúde, PDF p.177 (impressa p.175). [F3]

A janela do motor não é a janela da fonte. A fonte acima diz seis meses, e diz isso **para idosos**. O motor aplica **90 dias para toda a população**. Os 90 dias são calibração (ciclo trimestral do crônico), não transcrição da norma. Duas consequências para a auditoria: (i) um idoso internado há 4 meses **não** pontua neste canal, embora a fonte mande priorizá-lo; (ii) a janela única ignora que a fonte diferencia por faixa. Correção prevista: janela por perfil.

Canal B • Atraso na visita 0 a 10

Quanto o tempo sem visita passou do **prazo de visita** daquele paciente (página 5). Pontua proporcional, com teto quando o paciente **dobra o prazo**.

$$\text{atraso} = \text{dias sem visita} - \text{prazo} \cdot \text{pontos} = 10 \times \min(\text{atraso} \div \text{prazo} ; 1)$$

Ex. crônico (prazo 90 d): em dia $\rightarrow 0 \cdot 135 \text{ d} \rightarrow 5 \cdot \geq 180 \text{ d} \rightarrow 10$. Paciente **nunca visitado** entra com atraso máximo $\rightarrow 10$.

PARÂMETRO	VALOR	CLASSE	POR QUÊ
punir atraso	sim	NORMA	A Carteira fixa frequência mínima por linha de cuidado; passar do prazo é descumprimento de cadência, não preferência do agente.
rampa linear	proporcional	CALIBRAÇÃO	Substitui o degrau binário da v0.1. Critério: evitar que o paciente troque de faixa a cada ressincronização do Vitacare (<i>flapping</i>) por variação de um dia.
teto em 2× o prazo	2×	CALIBRAÇÃO	Quem dobrou o prazo já é prioridade máxima do canal; além disso a diferença deixa de ser acionável para o ACS.
soma dos canais	$\min(25, A+B)$	CALIBRAÇÃO	Evento + prazo vencido juntos representam a pior falha de cuidado, por isso somam; o teto de 25 preserva o orçamento do componente.

Por que “atraso” e não “tempo sem visita”. O score não olha o gap absoluto — olha o gap **relativo ao prazo daquele paciente**. 100 dias sem visita é atraso grave para uma gestante (prazo 30 d) e está em dia para um paciente geral (prazo 180 d). É o que torna o componente comparável entre linhas de cuidado.

Base pela linha de cuidado usa o mais curto que se aplica

Cada paciente tem um prazo próprio até a próxima visita. A base vem da linha de cuidado: gestante 30 d · criança 0–6 45 d · crônico HAS/DM 90 d · geral 180 d.

“Portanto, os ACS devem realizar visita domiciliar com periodicidade baseada na avaliação de risco e na vulnerabilidade, com frequência mínima :”

- “Diária : tuberculose e hanseníase;”
- “Semanal : gestantes de alto risco, crianças até 30 dias;”
- “Mensal : gestantes de risco habitual, crianças de 1 mês a 1 ano, acamados, Cartão Família Carioca (CFC);”
- “Trimestral : hipertensos, diabéticos, crianças de 1 a 2 anos;”
- “Semestral : crianças de 2 a 6 anos, idosos (≥ 60 anos) e Auxílio Brasil.”

Carteira de Serviços da APS – SMS-Rio, 2021, PDF p.47 (impressa p.46); repetida em PDF p.88 (impressa p.87). [F2]

PARÂMETRO	VALOR	CLASSE	POR QUÊ / A CONTA
gestante	30 d	DERIVADO	“Mensal: gestantes de risco habitual” → 30 dias.
crônico HAS/DM	90 d	DERIVADO	“Trimestral: hipertensos, diabéticos” → 90 dias.
geral	180 d	DERIVADO	“Semestral: (...) idosos (≥ 60 anos)” → 180 dias, aplicado como piso geral da população.
criança 0–6	45 d	CALIBRAÇÃO	Elo mais fraco desta folha. A Carteira parte 0–6 em três cadências (mensal 1m–1a; trimestral 1–2a; semestral 2–6a) e o dataset só traz a faixa “0–6”. 45 d é um meio-termo puxado para a criança mais nova. Correção: idade em dias.
piso (1_min)	7 d	DERIVADO	Linha “Semanal” da tabela → 7 dias. É a cadência mais curta que o motor consegue produzir hoje, já que TB e hanseníase (linha “Diária”) não têm flag no dataset.
combinar linhas	mín()	DERIVADO	A norma diz “frequência mínima”. Logo, em sobreposição vale a mais curta: gestante diabética → mín(30, 90) = 30 d, e não 90.

Exemplo trabalhado conferido contra o motor

Gestante diabética, a mais distante da equipe. Duas linhas de cuidado se aplicam (gestante e crônico) e ela tem duas condições clínicas (gestação + diabetes).

$$\text{base} = \text{mín}(30 ; 90) = 30 \quad \cdot \quad \text{dist} = 1 \rightarrow \times 0,60 \quad \cdot \quad \text{extra} = 1 \rightarrow \times 0,85$$
$$\text{prazo} = \text{máx}(7 ; 30 \times 0,60 \times 0,85) = 15,3 \text{ dias}$$

O prazo dela cai de 30 para 15,3 dias. Aos 30 dias sem visita, o atraso é de 14,7 d — 96% do prazo — e o canal B entrega 9,6, que o motor arredonda para C₃ = 10, o teto do canal. Uma gestante diabética perto do posto, no mesmo dia, teria prazo de 25,5 d, atraso de 4,5 d e C₃ = 2.

Leitura para auditoria. Repare que nenhum dos dois fatores sozinho produz esse prazo: é a combinação de linha de cuidado, carga clínica e acesso geográfico em um único número. É por isso que o prazo é gravado paciente a paciente na saída do motor (campo 1_eff) — sem ele, o “atraso” do C₃ não é auditável.

O prazo encurta para quem precisa de mais atenção distância e fragilidade

$$\text{prazo} = \text{máx}(7; \text{base} \times (1 - 0,40 \cdot \text{dist}) \times (1 - \text{mín}(0,15 \cdot \text{extra}; 0,45)))$$

dist = ranking de distância ao posto dentro da própria equipe (0 = mais perto, 1 = mais longe) · extra = nº de condições crônicas além da 1ª.

PARÂMETRO	VALOR	CLASSE	POR QUÊ
encurtar por risco	sim	NORMA	É a regra-mãe do motor: risco identificado ⇒ visitas mais frequentes.
distância (gamma)	até -40%	CALIBRAÇÃO	O fator é norma (barreira geográfica agrava risco de acesso); a magnitude de 40% não é. O ranking é por quantil dentro da equipe, então “longe” se recalibra sozinho entre favela e área plana.
condição extra (delta)	-15% cada	CALIBRAÇÃO	O fator é norma (multimorbidade entra na estratificação); a magnitude não é.
teto (delta_cap)	-45%	CALIBRAÇÃO	Impede que o encurtamento por comorbidade zere o prazo sozinho.

- “Pode ser que seja identificada uma situação de risco e isso demandará a realização de outras visitas com maior frequência.”
Manual do ACS – Ministério da Saúde, PDF p.50 (impressa p.48). [F6]
- “A situação de risco pode ser agravada por obstáculos ou fatores que dificultam ou impedem as pessoas de terem acesso às unidades de saúde, como: • Localização do serviço com barreiras geográficas ou distante da comunidade ;”
Manual do ACS – Ministério da Saúde, PDF p.30 (impressa p.28). [F6]
- “(…) pela avaliação da estratificação de risco e vulnerabilidade clínica (ex.: idade, cuidados paliativos, multimorbidade, polifarmácia, mobilidade, dependência funcional, dentre outros).”
Carteira de Serviços da APS – SMS-Rio, 2021, PDF p.47 (impressa p.46). [F2]

Por que a distância entra no prazo e não no score. Distância não torna o paciente mais doente — torna a unidade menos alcançável, então ele depende mais da visita. Entrando no prazo, ela antecipa a visita sem inflar artificialmente a gravidade clínica do caso.

O que o motor deliberadamente não usa verificável no código

Tão importante quanto o que entra no score é o que fica de fora. Estes pontos são estruturais — não são configuração, estão na forma do código e são cobertos por teste.

NÃO ENTRA	GARANTIA	POR QUÊ
sexo · raça/cor	ausentes de PatientFeatures	Existem na base da SMS-Rio, mas não são lidos pelo motor. Nenhum campo demográfico além de faixa etária alimenta o score — barreira contra discriminação algorítmica.
identidade da ACS	test_acs_identity_not_in_features	O score do paciente não muda conforme quem vai visitá-lo. Priorização e alocação são etapas separadas.
rota e vizinhança	test_scoring_does_not_import_allocation	O módulo de score não importa nada da alocação. Conveniência logística nunca altera prioridade clínica — só a ordem de percurso dentro da mesma faixa.
qualquer LLM	função pura, sem I/O	Mesma entrada, mesma saída (test_same_input_same_output). A decisão é inspecionável em SQL/Python — requisito de auditabilidade clínica.

Onde a IA entra, então. Fora da decisão de prioridade: em texto de apoio ao ACS e em resumo de caso. Nenhum modelo de linguagem participa do cálculo do score ou da ordenação da lista.

Três faixas, e por que são três

estrutura

O score vira uma de três faixas: **Alto, Médio, Habitual**. A estrutura de três estratos não é invenção do motor — é a da escala nacional de risco familiar usada na Atenção Primária brasileira, e a mesma que a SMS-Rio adota na Escala de Risco Familiar da Ficha A.

Score total 5 e 6 → **R1 - risco menor**
Score total 7 e 8 → **R2 - risco médio**
Score total acima de 9 → **R3 - risco máximo**

Escala de Risco Familiar de Coelho-Savassi (ERF-CS), Quadro 2 – JMPHC, 2012, p.2. [F7]

Modo quantil

padrão

A cada rodada, **por equipe**, os cortes saem da distribuição real daquela população: topo **3%** → **Alto** · **17%** seguintes → **Médio** · resto → **Habitual**. Por isso não são valores fixos — acompanham a equipe.

“Áreas onde as famílias apresentem escore familiar final muito elevado, como por exemplo, zona rural precária, ou aglomerados não urbanizados: recomenda-se elevar o ponto de corte para a priorização das famílias, e considerar aquela microárea (ou área) como de risco.”

“Permanecem atuais os questionamentos acerca **pontos de corte mais flexíveis**, áreas de risco e inclusão de novas sentinelas.”

ERF-CS – JMPHC, 2012, p.6. [F7]

Este é o fundamento do modo quantil: a própria escala nacional reconhece que **corte fixo não funciona em território de alta prevalência** e recomenda elevá-lo. O motor faz isso automaticamente, por equipe, a cada rodada — em vez de exigir recalibração manual por microárea.

PARÂMETRO	VALOR	CLASSE	POR QUÊ
corte móvel por equipe	quantil	NORMA	Recomendação expressa da escala nacional (trecho acima).
fração Alto	3%	CALIBRAÇÃO	Critério operacional , verificável: a PNAB limita a microárea a 750 pessoas por ACS e a capacidade configurada é de 25 visitas/ACS/semana . 3% de 750 ≈ 22 pacientes — cabe em uma semana de trabalho. Ou seja: a faixa Alto é dimensionada para ser inteiramente visitável toda semana .
fração Médio	17%	CALIBRAÇÃO	Fecha 20% de população priorizada. Não há norma nem conta de capacidade que fixe 17% — é o parâmetro mais discricionário do motor.
modo absoluto	≥61 · 31-60 · ≤30	CALIBRAÇÃO	Fallback herdado da v0.1, usado quando a distribuição é degenerada (todos com o mesmo score).

“cada ACS deve realizar as ações previstas nas regulamentações vigentes e nesta portaria e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja população **não ultrapasse 750 pessoas** ;”

PNAB – Portaria GM/MS nº 2.436/2017, Anexo, item 3.4. [F5]

Efeito colateral do quantil, declarado. Com corte por quantil, **toda equipe sempre terá ~3% em Alto** — mesmo uma equipe inteira saudável. A faixa é **relativa à população da equipe**, não uma afirmação clínica absoluta. Para leitura epidemiológica entre equipes, usar o **score bruto**, nunca a faixa. É o preço da recomendação de corte flexível da ERF-CS.

Divergências declaradas para decisão da SMS

TEMA	O QUE A NORMA DIZ	O QUE O MOTOR FAZ	ENCAMINHAMENTO
Janela de evento	Guia ACS: “queda ou internação nos últimos seis meses”, para idosos.	90 dias, para toda a população.	Janela por perfil clínico; testar 180 d para 66+.
Peso das crônicas	ERF-CS pontua HAS = 1 e DM = 1 — iguais e puramente aditivos.	Pesos desiguais e decrescentes [15, 12, 8].	Deliberado (2ª comorbidade agrega menos risco marginal), mas sem validação empírica.
Peso do social	ERF-CS: saneamento 3, desemprego 2 > HAS 1, DM 1.	Social ≤ 15; clínico ≤ 35 (relação invertida).	Decisão de política da SMS, não de engenharia.
Criança 0-6	Carteira: três cadências (30 / 90 / 180 d) dentro da faixa.	Um único prazo de 45 d.	Exige idade em dias na base; hoje é limitação de dado.
Corte de idoso	Carteira: ≥ 60. ERF-CS: > 70.	66+ (faixa etária do dataset).	Faixa 60–65 fica fora do C ₂ . Pedir idade exata.
TB e hanseníase	Carteira: cadência diária.	Não pontua — não há flag no dataset.	Captura via Ficha B-TB; override de faixa.
Puerpério e lactante	Lei 11.350, art. 3º, §3º, IV: acompanhar “no parto e no puerpério” e a lactante nos seis meses seguintes.	Não pontua. O motor tem o parâmetro (postpartum.window_days = 42) mas ele está enabled: false — falta dias pós-parto na base.	Lacuna frente à lei. Hoje a paciente zera C ₁ e C ₂ no dia do parto. Ligar assim que o campo existir.
Acamado	Carteira: cadência mensal.	Não pontua — sem campo na base.	Captura em campo pelo app.
Unidade de análise	ERF-CS pontua a família.	PRIO-ACS pontua o paciente.	Intencional (a lista do ACS é de pessoas), mas muda a semântica do score.
Nome do C ₁	ICSAP é indicador de internações, apurado sobre altas hospitalares — não é escore de risco de pessoa.	Código e banco ainda usam c1_icsap / score_icsap, e o 1-pager dizia “risco de internação evitável”.	Folha e 1-pager já corrigidos. Renomear no código e na coluna segue pendente.
Documentação interna	—	docs/engine-spec.md ainda descreve a v0.1 (C ₃ binário, janela 60 d, cortes fixos) e repete “Captures risk of preventable hospitalization”.	Atualizar para v0.2 — auditar pela spec hoje leva à fórmula errada.

Fontes documento · trecho · onde conferir

1. [F1] **Portaria SAS/MS nº 221, de 17 de abril de 2008** — Lista Brasileira de ICSAP, 19 grupos CID-10. Usada em: C₁ — **critério de seleção das condições**, não de pontuação. bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2008/prt0221_17_04_2008.html
2. [F2] **Carteira de Serviços da Atenção Primária — SMS-Rio, 2021** — periodicidade mínima de visita (PDF p.47 / impressa p.46, repetida em PDF p.88 / impressa p.87); multimorbidade; Cartão Família Carioca. Usada em: C₁, C₂, C₄, prazo de visita, janela do C₃. subpav.org/download/impressos/Livro_CarteiraDeServicosAPS_2021_20211229.pdf
3. [F3] **Guia Prático para o ACS — Ministério da Saúde** — critérios de maior frequência de visita ao idoso (PDF p.177 / impressa p.175). Usada em: C₁, C₂, C₃. 189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf
4. [F4] **Lei nº 11.350/2006, art. 3º, §3º, IV e V** — redação da Lei nº 13.595/2018. Visitas regulares e periódicas a gestante e criança; grupos com maior vulnerabilidade social. Usada em: C₂, C₄. planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113595.htm
5. [F5] **PNAB — Portaria GM/MS nº 2.436/2017** — Anexo: priorização por vulnerabilidade e risco epidemiológico; atribuição III do ACS; limite de 750 pessoas por microárea. Usada em: C₄, faixas. bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
6. [F6] **Manual do ACS — Ministério da Saúde** — situações de risco (PDF p.29 / impressa p.27); barreiras geográficas e determinantes sociais (PDF p.30 / impressa p.28); risco ⇒ maior frequência (PDF p.50 / impressa p.48). Usada em: C₁, C₄, prazo de visita. 189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf
7. [F7] **Escala de Risco Familiar de Coelho-Savassi (ERF-CS)** — Savassi LCM, Lage JL, Coelho FLG. JMPHC, 2012 (Quadros 1–3 e ponto de corte, pp.2, 5 e 6). Usada em: três faixas, modo quantil, comparação de pesos clínico × social. jmphc.com.br/jmphc/article/view/155

Como reproduzir esta folha. Fonte do documento em docs/src/priorizacao-visitare-regras.html. Os valores conferem com [engine/scoring.py](#) e [config/rio-de-janeiro.yaml](#) do repositório [Visitare/visitare-engine](#). Trechos citados extraídos dos PDFs originais com `pdftotext -layout`; a numeração “PDF p.N” é a página do arquivo e “impressa p.M” a impressa no rodapé da publicação.